

УДК 614.2:614.212:616-051

К.Х.Жапаев

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

К вопросу экспертизы качества медицинской помощи

Аннотация. Совершенствование управления качеством медицинских услуг

Совершенствование современной системы управления качеством медицинской помощи на уровне медицинской организации – это важный рычаг повышения качества и отвечает требованию реформы здравоохранения.

Ключевые слова: Качество медицинской помощи, экспертиза

В Послании Президента Республики Казахстана Н.А.Назарбаева народу Казахстана от 28.01.2011г. «Построим будущее вместе» указано, что «Одним из направлений государственной политики на новом этапе развития нашей страны должно стать улучшение качества медицинских услуг и развитие высокотехнологичной системы здравоохранения [1].

Качество медицинских услуг является комплексным понятием и зависит от множества емких причин, среди которых следует выделить материально-техническую оснащенность медицинских организаций, уровень профессионализма и наличие мотивации клинических специалистов к его повышению, внедрение современных технологий управления процессами организации и оказания медицинской помощи, внедрение эффективных методов оплаты медицинской помощи. Совершенствование управления качеством медицинских услуг занимает важное место в контексте стратегического развития здравоохранения Казахстана до 2020 года».

В соответствии с вышеуказанным, а также на основе проведенного анализа современного состояния здоровья населения и системы здравоохранения Республики Казахстан были определены приоритетные стратегические направления и механизмы реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011 – 2015 годы (утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года № 1113), в числе которых отмечено улучшение качества медицинской помощи, оказываемой населению страны [2].

Совершенствование современной системы управления качеством медицинской помощи на уровне медицинской организации – это важный рычаг повышения качества и отвечает требованию реформы здравоохранения.

Значительный прогресс в медицине в промышленно развитых странах, достигнутый в течение последних десятилетий, во многом объясняется внедрением новых подходов к управлению в сфере здравоохранения, основанных на концепции непрерывного повышения качества.

Теоретические основы практического внедрения в здравоохранение концепции непрерывного повышения качества были заложены доктором AvedisDonabedian, который выделил три главных направления работы по

управлению качеством медицинской помощи – совершенствование структуры, процесса и результата. Взаимосвязь структуры, процесса и результата получила название «триады Донабедиана». По А.Донабедиану, качество медицинской помощи определяется использованием медицинской науки и технологии с наибольшей выгодой для здоровья человека, при этом без увеличения риска.

Как известно, различают несколько основных характеристик качества, которые имеют отношение как к клиническому и организационному аспектам оказания медицинской помощи, так и к работе вспомогательных служб: профессиональная компетенция; доступность; результативность; межличностные взаимоотношения; эффективность; непрерывность; безопасность; удобство.

Указанные характеристики качества включают в себя почти все аспекты функционирования системы здравоохранения. Важность этих характеристик становится ясной в контексте требований, которые предъявляются со стороны пациентов и медицинских работников. Для пациентов качество медицинской помощи определяется тем, насколько она отвечает их нуждам, является своевременной и насколько вежлив, внимателен медперсонал, оказывающий эту помощь. Пациенты чаще всего обращают внимание на результативность и доступность, взаимоотношения между ними и медперсоналом, а также на непрерывность медицинской помощи, как наиболее важные характеристики качества. Медицинские работники обычно обращают больше внимания на профессиональную компетенцию, эффективность и безопасность. С их точки зрения, качество медицинской помощи подразумевает наличие у медработника навыков, ресурсов и условий, необходимых для улучшения здоровья пациентов, знаний и умения выполнять профессиональные обязанности [3].

Достижение всех перечисленных характеристик медицинской помощи, совокупность которых определяет ее качество и выполнения требований, предъявляемых как пациентами, так и медицинскими работниками, возможно при внедрении новых подходов к управлению лечебно-диагностическим процессом.

В целях улучшения качества оказания медицинской помощи необходимо совершенствование организации внешней и внутренней экспертиз качества медицинских услуг в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 24.03.2011года № 152 «Об утверждении Правил организации и проведения внутренней и внешней экспертиз качества медицинских услуг», а именно:

- проведение службой внутреннего контроля (аудита) анализа оказания медицинской помощи, клинической деятельности медицинской организации, выявление фактов нарушения порядка оказания медицинской помощи и стандартов в области здравоохранения, а также рассмотрение в срок, не превышающий пяти

дней, обращений пациентов, находящихся на лечении, с внесением службой внутреннего контроля (аудита) руководителю медицинской организации предложений по устранению выявленных причин и условий снижения качества оказываемых медицинских услуг;

- анализ учетной и отчетной документации субъекта здравоохранения с целью сравнительного анализа показателей деятельности субъекта здравоохранения за определенный период работы, со средне-республиканскими и средне-областными показателями состояния здоровья населения в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

- проведение клинического аудита путем изучения подробного ретроспективного и/или текущего анализа проведенных лечебно-диагностических мероприятий на предмет их соответствия установленным стандартам.

Система обеспечения качества медицинской помощи в организациях здравоохранения Республики Казахстан в том виде, как она действует в настоящее время, является механизмом контроля и внешнего воздействия на деятельность медицинской организации и обеспечивает лишь выполнение минимальных стандартов оказания медицинских услуг. Данный подход не обеспечивает мотивации медицинского персонала к осуществлению объективной критической оценки собственной профессиональной деятельности и постоянному совершенствованию получаемых результатов.

Совершенно очевидно, наряду с совершенствованием государственного контроля в сфере здравоохранения, необходимо развивать систему управления качеством медицинской помощи на уровне медицинской организации и независимую экспертизу.

Список литературы

1. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Построим будущее вместе», 2011, 42 с.
 2. Государственная программа «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы, от 29 ноября 2010 года.
- Назаренко Г.И., Полубенцева Е.И. Управление качеством медицинской помощи. – М: Медицина, 2000. – 368 с.

Тұжырым

К.Х. Жапаев

Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты

Медициналық қызмет сапасын басқаруды жетілдіру

Медициналық ұйым деңгейінде медициналық көмек сапасын басқарудың заманауи жүйесін жетілдіру денсаулық сақтау реформаларының талаптарына жауап беретін және сапаны жақсартуда маңызды құрал болып табылады.

Түйінді сөздер: медициналық көмек сапасы, сапатама.

Summary

K.H. Zhapayev

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Improvement of quality management of medical services

Improvement of a modern control system by quality of medical care at the level of the medical organization is an important lever of improvement of quality and meets the requirement of reform of health care.

Keywords: quality of care, expertise